

O preço da pressa

A taxa que o médico paga para antecipar o plantão está correta. A conta continua custando cinco plantões por ano — e é isso que ninguém calcula.

Antecipação de recebíveis

Médicos plantonistas

Agosto de 2026

Sumário executivo

O plantão foi dado em março. O dinheiro cai em maio. No meio do caminho, a conta de luz venceu. É nesse intervalo que nasce um mercado inteiro — e uma conta que quase nenhum médico já fez.

Este estudo começou procurando um vilão e não encontrou nenhum. A taxa praticada no mercado de antecipação de plantões, quando se consegue vê-la, está corretamente precificada para o risco que ela carrega. O achado é outro, e é mais desconfortável: **o preço certo, cobrado indefinidamente, custa mais do que o preço errado cobrado uma vez.**

26,8%

o custo anual real da antecipação a 2% ao mês — praticamente igual ao financiamento de um carro

5,0

plantões por ano trabalhados sem remuneração — a mesma fração em qualquer faixa de renda

R\$ 46 mil

o tamanho real do problema, que ele paga R\$ 11.088 por ano para não resolver

1. O prazo do hospital é o multiplicador, não a taxa. Na convenção praticada no mercado — taxa mensal cobrada pro rata die — o custo anual é o mesmo em qualquer prazo: 26,8%. O que triplica é a conta. Um médico pago em 90 dias entrega R\$ 22.176 por ano; o mesmo médico, à mesma taxa, pago em 30 dias, entrega R\$ 7.392. **Negociar o prazo com o contratante vale três vezes mais que negociar a taxa com a financeira.**

2. E o preço, nessa convenção, está certo. 26,8% ao ano fica entre a média do crédito livre para empresas (24,4%) e o crédito consignado (28,3%), praticamente empatado com o financiamento de veículo (26,4%). Para crédito de curto prazo lastreado em recebível, é onde o preço deveria estar. Este estudo não tem denúncia a fazer.

3. O descasamento de caixa é um nível, não um fluxo. Esta é a conclusão central. O plantonista que trabalha todo mês recebe uma renda por mês — apenas atrasada. O atraso cobra uma vez, no começo. No caso-base, esse "uma vez" vale R\$ 46.200.

4. Quem antecipa todo mês não tem um custo. Tem uma dívida. Um saldo rotativo de R\$ 46.200 que nunca amortiza, ao custo de R\$ 924 por mês. Nenhum médico assinaria um financiamento de veículo desse tamanho sem saber o prazo. Milhares carregam exatamente isso sem nunca terem chamado de dívida.

5. Existe um ponto abaixo do qual não há saída. Com esforço mensal de até R\$ 924, o saldo nunca cai — o dinheiro paga o deságio e acaba. A R\$ 1.500 por mês, são 48 meses. A R\$ 2.500, 23. A diferença entre as duas trajetórias é de R\$ 14.247 em deságio pago.

6. Negociar a taxa resolve pouco. Achar excedente resolve tudo. Baixar a taxa de 2,0% para 1,5% economiza R\$ 231 por mês e encurta a saída para 42 meses. Encontrar R\$ 1.000 de excedente no próprio orçamento, sem mexer na taxa, encurta para 23 meses. **O segundo caminho vale quase o dobro do primeiro** — e é o único que continua rendendo depois que a dívida acaba.

O QUE ESTE ESTUDO NÃO É

Não é uma denúncia. As empresas de antecipação resolvem um problema real, assumem risco de crédito e cobram um preço compatível com esse risco. O problema não está em quem oferece, nem no quanto se cobra. Está em contratar recorrentemente, por anos, um instrumento desenhado para uso pontual — sem nunca converter a taxa cotada em taxa anual e sem nunca perguntar quanto tempo isso vai durar.

Como este estudo foi feito

Todas as premissas foram fixadas antes de qualquer cálculo, e estão reproduzidas no fim do documento. O caso-base foi definido antes de olhar qualquer resultado.

LIMITAÇÃO DE DADO — LEIA ANTES DE TUDO

Não existe série pública de taxas de antecipação de plantão médico. Verificamos cinco operadores que atendem médicos plantonistas no Brasil. Todos anunciam transparência de taxas na página inicial. **Nenhum publica uma tabela.** O preço só aparece dentro do aplicativo, depois do cadastro, e varia por convênio com o hospital ou grupo médico.

O caso-base de 2% ao mês vem de propostas reais observadas em campo, não de uma média de mercado — que não existe. **Este estudo não afirma qual é a taxa de mercado.** Ele entrega uma grade de custo para toda a faixa plausível e ancora essa faixa em números públicos e verificáveis. Cada leitor localiza a própria taxa na grade.

O caso-base

Um anestesista em São Paulo, rede privada, com **14 plantões de 12 horas a R\$ 2.200** — R\$ 30.800 por mês e R\$ 183,33 por hora. São 168 horas mensais, o equivalente a uma jornada integral. O valor do plantão é de mercado observado, não piso sindical.

POR QUE NÃO USAMOS O PISO DA FENAM COMO CASO-BASE

A Federação Nacional dos Médicos publica um piso de referência para negociação. Para 2026, o site da própria federação lista R\$ 3.168,38 para o plantão de 12 horas — enquanto sindicatos filiados publicam R\$ 3.324,17 para o mesmo ano, aplicando um INPC diferente. **Registramos a divergência e não usamos nenhum dos dois.**

O motivo é mais importante que o número: **piso de negociação não é preço praticado.** Fontes de mercado situam a média nacional real entre R\$ 1.200 e R\$ 1.500 para 12 horas, e a rede privada de São Paulo entre R\$ 2.000 e R\$ 2.500. Construir um estudo sobre o piso produziria números inflados em toda a cadeia. Usamos valores observados e mostramos três perfis lado a lado — incluindo o piso, para que se veja a distância.

Perfil · 14 plantões de 12 horas	Plantão	Por mês	Hora bruta	Deságio por mês	Hora após antecipar	Plantões grátis por ano
Anestesista · São Paulo, rede privada	R\$ 2.200	R\$ 30.800	R\$ 183,33	R\$ 924	R\$ 177,83	5,04
Generalista · média nacional	R\$ 1.250	R\$ 17.500	R\$ 104,17	R\$ 525	R\$ 101,04	5,04
Piso de referência FENAM 2026	R\$ 3.168	R\$ 44.357	R\$ 264,03	R\$ 1.331	R\$ 256,11	5,04

Tabela 1 · Três perfis com a mesma jornada, prazo de 45 dias e taxa de 2% ao mês. A linha destacada é o caso-base.

A última coluna é o achado silencioso desta tabela: **os três perfis perdem exatamente o mesmo número de plantões por ano**. A antecipação não cobra proporcionalmente menos de quem ganha menos. Ela cobra a mesma fração do tempo de todo mundo — o que muda é apenas quanto vale esse tempo.

As regras do modelo

- A taxa do caso-base é de **2% ao mês, cobrada pro rata die** até o vencimento — convenção confirmada nas propostas observadas. O deságio efetivo, num prazo de 45 dias, é de 3,0%.
- O deságio também é tratado como **parâmetro do leitor**, testado de 1% a 5%, nas duas convenções encontradas no mercado.
- O prazo de pagamento é testado em **30, 45, 60 e 90 dias**, faixa relatada pelos próprios operadores em suas páginas de apresentação.
- O custo de oportunidade usa **CDI líquido de imposto de renda** — 10,77% ao ano com a alíquota de 22,5%. Escolhemos o CDI justamente por ser conservador: é o ativo mais simples e mais acessível do mercado brasileiro. Qualquer alternativa mais rentável aumentaria o custo relativo da antecipação, não o contrário.
- As projeções de longo prazo usam **IPCA + 6% ao ano em termos reais**, premissa padrão da casa. Nenhum número deste documento é nominal; todos já estão descontados da inflação.
- Ficaram **de fora**: IOF, tarifas de cadastro, taxa ad valorem, efeitos tributários na pessoa jurídica do médico e custo de corretagem. Todas essas omissões **favorecem a antecipação** — o custo real é maior que o apresentado aqui.

DIVERGÊNCIA ENTRE FONTES, REGISTRADA

Para o IPCA acumulado em 12 meses até julho de 2026, encontramos 4,44% em uma fonte agregadora e 4,64% em outra, ambas citando o IBGE. Ancoramos em 4,64% e registramos a divergência em vez de escolher em silêncio. O impacto sobre as conclusões é nulo: nenhum resultado deste estudo depende do IPCA na segunda casa decimal.

O que o mercado publica e o que ele não publica

A primeira descoberta deste estudo não é um número. É a ausência de um.

Procuramos a tabela de preços de cinco operadores de antecipação para médicos. As páginas falam em taxa justa, taxa transparente, condições competitivas, ausência de custos ocultos. Uma delas informa que o médico tem limite pré-aprovado de R\$ 15 mil e que a análise leva de 24 a 48 horas. Outra diz que o hospital não paga nada e que a taxa é cobrada do médico. Nenhuma informa quanto.

Isso não é ilegal nem incomum — precificação por risco de crédito e por convênio raramente é publicada. Mas tem duas consequências práticas. A primeira: **o médico não consegue comparar antes de se cadastrar**, e quando finalmente vê o número, ele aparece como um percentual pequeno ao lado de um botão de confirmar. A segunda é mais séria.

O ACHADO DESTA SEÇÃO

Nas propostas a que tivemos acesso, **não foi possível determinar, a partir do próprio documento, se existe custo além do deságio** — tarifa de cadastro, ad valorem ou IOF destacado. Quando o contrato não permite reconstruir o custo total, a taxa anunciada deixa de ser informação e passa a ser expectativa. Este estudo trabalha apenas com o deságio, o que significa que **todos os números aqui são pisos**.

Modalidade	Faixa declarada	Origem do número
Antecipação de recebíveis · empresas em geral	2% a 15%	Cora, guia de antecipação de recebíveis, 2026
Antecipação em plataforma de leilão · CET	1,49% a 4,5% ao mês	Antecipa Fácil, guia 2026
Antecipação salarial por aplicativo	5% a 15% ao mês	Antecipa Fácil, guia de antecipação salarial 2026
Antecipação salarial via convênio com a empresa	2% a 4%	SalaryFits, entrevista à imprensa
Consignado privado	1,2% a 3,2% ao mês	Antecipa Fácil, 2026
Antecipação de plantão médico	não publicada	nenhum dos cinco operadores verificados divulga tabela

Faixas declaradas por fontes de mercado para operações análogas. Nenhuma delas se refere especificamente a plantão médico.

A faixa publicada nas modalidades análogas é larga demais para servir de referência — de 1,2% a 15% ao mês, uma diferença de doze vezes no preço do mesmo serviço. Num mercado assim, o custo de não perguntar é a diferença entre pagar 20% e 88% ao ano.

O prazo é o multiplicador

Quase toda a atenção do médico vai para a taxa. Na convenção praticada no mercado, a taxa é a única coisa que não muda.

A antecipação de plantão é cotada como **taxa mensal cobrada pro rata die**: o percentual é multiplicado pelo tempo que falta até o vencimento. Dois por cento ao mês sobre um plantão que cairia em 45 dias viram 3% de deságio; sobre um que cairia em 90 dias, viram 6%.

O efeito é contraintuitivo. Como preço e prazo crescem juntos, **o custo anual da operação é praticamente idêntico em qualquer prazo** — 26,8% ao ano, dos 30 aos 90 dias. Um médico que compare "taxas" entre dois contratos com prazos diferentes vai concluir, corretamente, que são iguais. E vai estar olhando para a variável errada.

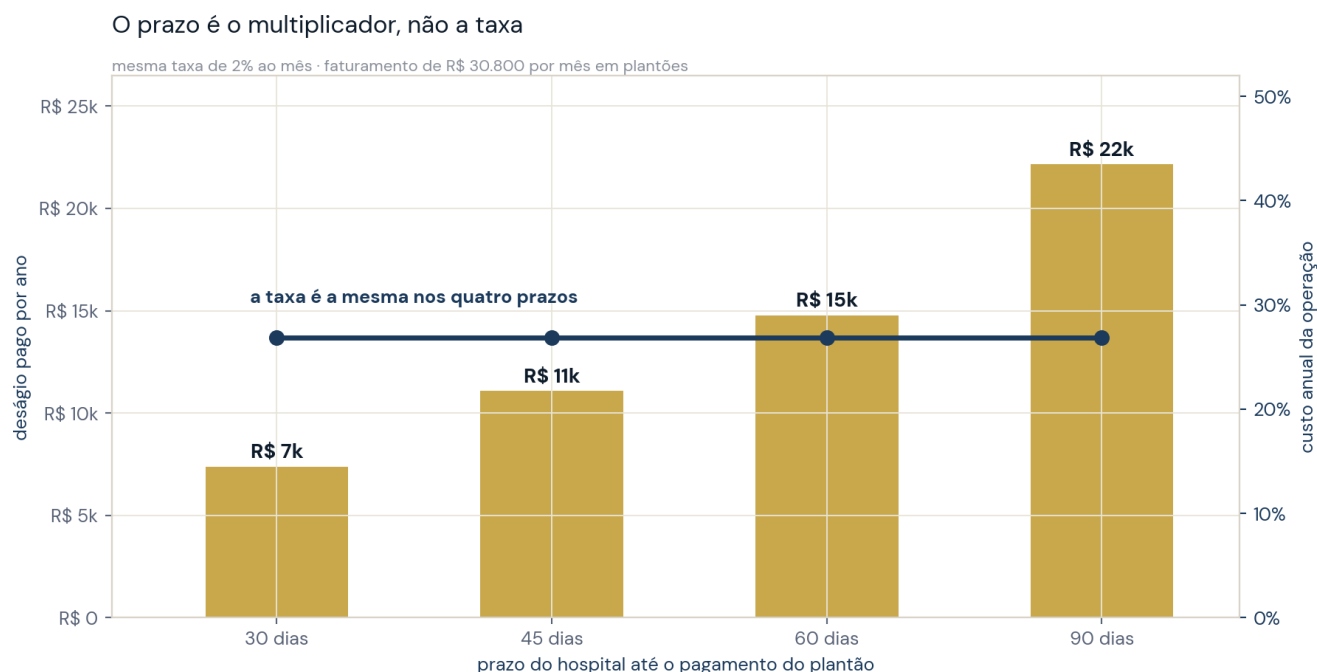


Gráfico 1 · Deságio pago por ano, por prazo de pagamento, mantendo a taxa constante em 2% ao mês. A linha azul é o custo anual da operação.

Prazo do hospital	Custo anual	Saldo devedor	Deságio por mês	Por ano	Plantões grátis por ano
30 dias	26,8%	R\$ 30.800	R\$ 616	R\$ 7.392	3,36
45 dias	26,8%	R\$ 46.200	R\$ 924	R\$ 11.088	5,04
60 dias	26,8%	R\$ 61.600	R\$ 1.232	R\$ 14.784	6,72
90 dias	26,8%	R\$ 92.400	R\$ 1.848	R\$ 22.176	10,08

Tabela 2 · O mesmo médico, a mesma taxa, quatro prazos de contratante.

O ACHADO CENTRAL DESTA SEÇÃO

Entre um contrato que paga em 30 dias e um que paga em 90, à taxa idêntica, a diferença é de **R\$ 14.784 por ano** e de **6,7 plantões** trabalhados de graça. Nenhuma negociação de taxa chega perto disso.

Isso muda para quem o médico deveria estar ligando. A conversa que mais economiza dinheiro não é com a empresa de antecipação. É **com o hospital, a cooperativa ou o grupo médico** — sobre o prazo de pagamento, que é a variável que realmente move a conta e que raramente entra em pauta.

A grade completa

Taxa ao mês	30 dias	45 dias	60 dias	90 dias
1,5%	20,2%	20,3%	20,4%	20,5%
2,0%	27,9%	28,0%	28,2%	28,5%
2,5%	36,1%	36,3%	36,6%	37,2%
3,0%	44,9%	45,3%	45,7%	46,6%
4,0%	64,3%	65,2%	66,1%	67,9%
5,0%	86,7%	88,2%	89,8%	93,3%

Tabela 3 · Custo anual equivalente de uma taxa mensal cobrada pro rata, por prazo. Repare que as colunas praticamente não se distinguem — é exatamente esse o ponto.

O preço está certo

Esta é a seção em que o estudo desarma a própria expectativa. A antecipação não é cara. Ela é crédito de curto prazo, precificado como crédito de curto prazo.

A 2% ao mês, o preço está no lugar certo

taxa anual sobre o saldo devedor · linhas do Banco Central em junho de 2026

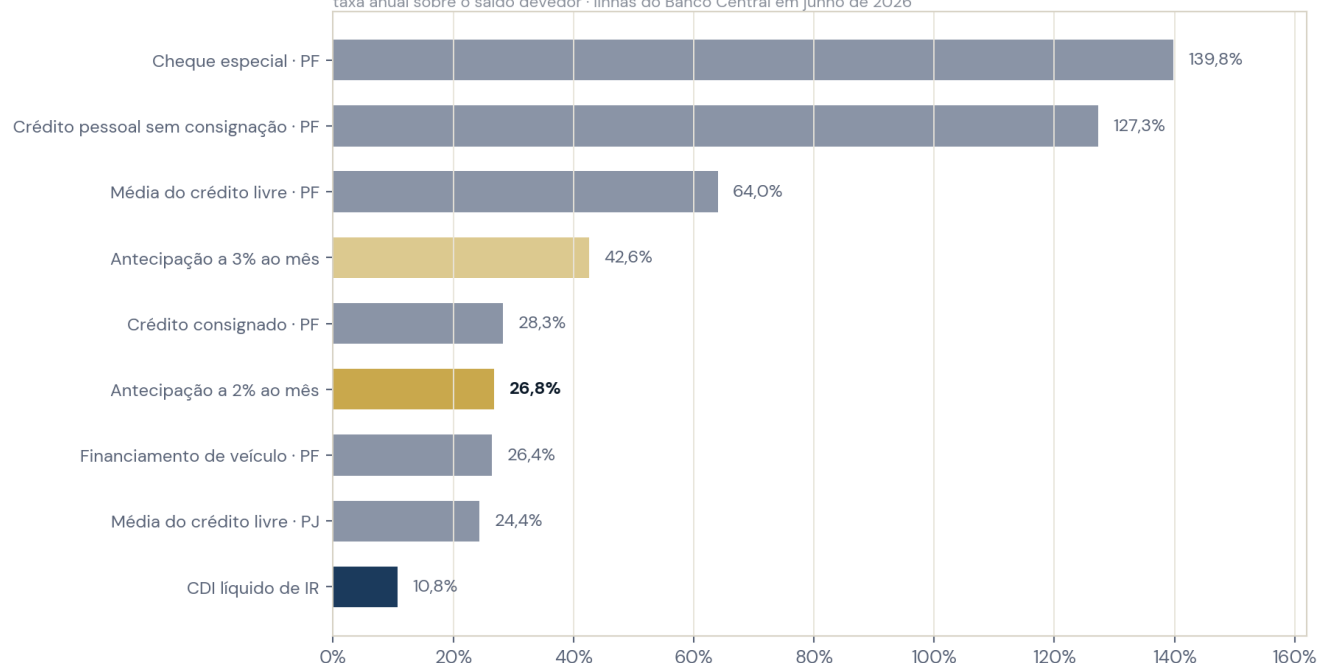


Gráfico 2 · Taxas médias das linhas de crédito no Brasil em junho de 2026, divulgadas pelo Banco Central em 30 de julho, com a antecipação posicionada na mesma régua.

Linha de crédito	Taxa média ao ano	Equivalente ao mês
Cheque especial · pessoa física	139,8%	7,56%
Crédito pessoal sem consignação · PF	127,3%	7,08%
Média do crédito livre · PF	64,0%	4,21%
Média do crédito livre · total	49,8%	3,43%
Crédito consignado · PF	28,3%	2,10%
Financiamento de veículo · PF	26,4%	1,97%
Média do crédito livre · PJ	24,4%	1,84%
Antecipação recorrente a 2% ao mês	26,8%	2,00%

Tabela 4 · Fonte: Estatísticas Monetárias e de Crédito do Banco Central, referência de junho de 2026.

A 26,8% ao ano, a antecipação a 2% ao mês é **mais barata que o crédito consignado** (28,3%), praticamente empatada com o financiamento de um carro (26,4%) e distante de qualquer coisa que se pareça com abuso — o cheque especial custa 139,8% e o crédito pessoal sem consignação, 127,3%.

Para o médico que está prestes a entrar no cheque especial, antecipar um plantão a 2% não é apenas aceitável: é a decisão financeiramente correta, por uma margem enorme. É exatamente para isso que o instrumento existe, e é por isso que ele existe.

POR QUE ISSO TORNA O PROBLEMA PIOR, E NÃO MELHOR

Um preço abusivo se resolve trocando de fornecedor. Um preço justo, não. Se a taxa já está onde deveria estar, **não há negociação capaz de resolver o problema** — e o médico que passa dois anos procurando uma taxa melhor está otimizando a variável errada. O dinheiro não está na taxa. Está na frequência.

A conclusão incômoda

O descasamento de caixa do plantonista é um problema de nível, não de fluxo. Cobra uma vez. Quem antecipa todo mês paga para sempre por um problema que só existia no primeiro mês.

Acompanhe a mecânica. Um médico começa a dar plantões em janeiro. O pagamento sai em 45 dias. Fevereiro é difícil, porque ele trabalhou e ainda não recebeu. Março também. A partir de abril, porém, algo muda: **ele passa a receber todo mês** — o dinheiro de fevereiro e meio de março, chegando com atraso, mas chegando mensalmente. O fluxo se normaliza sozinho.

O que nunca se normaliza é o **buraco inicial**. Ele vale, no caso-base, R\$ 46.200 — a renda mensal multiplicada pelo prazo em meses. E fica lá, parado, para sempre, a menos que alguém o preencha.

A VIRADA DE CHAVE

Quem antecipa todos os meses vendeu antecipadamente os recebíveis que fariam a normalização acontecer. Quando o dinheiro chega, já pertence a outra pessoa. Então ele antecipa o mês seguinte. E o seguinte. Isso não é um custo recorrente — é **uma dívida rotativa de R\$ 46.200 que nunca amortiza**, rolada indefinidamente ao custo de R\$ 924 por mês.

Prazo do hospital	Saldo devedor	Deságio por mês	Por ano	Taxa a.a.	Minutos grátis por plantão	Plantões grátis por ano
30 dias	R\$ 30.800	R\$ 616	R\$ 7.392	26,8%	14 min	3,4
45 dias	R\$ 46.200	R\$ 924	R\$ 11.088	26,8%	22 min	5,0
60 dias	R\$ 61.600	R\$ 1.232	R\$ 14.784	26,8%	29 min	6,7
90 dias	R\$ 92.400	R\$ 1.848	R\$ 22.176	26,8%	43 min	10,1

Tabela 5 · A antecipação recorrente vista como dívida, a 2,0% ao mês pro rata. A linha destacada é o caso-base.

A coluna da direita é a mais difícil de encarar. Um médico com pagamento em 90 dias que antecipa sistematicamente a 2% ao mês trabalha **10,1 plantões por ano de graça** — 6% de tudo o que ele plantonar na vida, sem remuneração alguma. E o preço que ele paga por isso está correto.

O que isso faz com o valor da hora

O plantão de 12 horas do caso-base paga R\$ 183,33 por hora. Com deságio de 3,0%, a hora efetiva cai para R\$ 177,83. Traduzido para a unidade que importa: de cada plantão de doze horas, **22 minutos são trabalhados sem remuneração**. Vinte e dois minutos, todo plantão, para sempre.

O ponto em que o esforço vira armadilha

Sair da antecipação é matematicamente idêntico a quitar um empréstimo — e tem a mesma armadilha: abaixo de um certo pagamento, o saldo nunca cai.

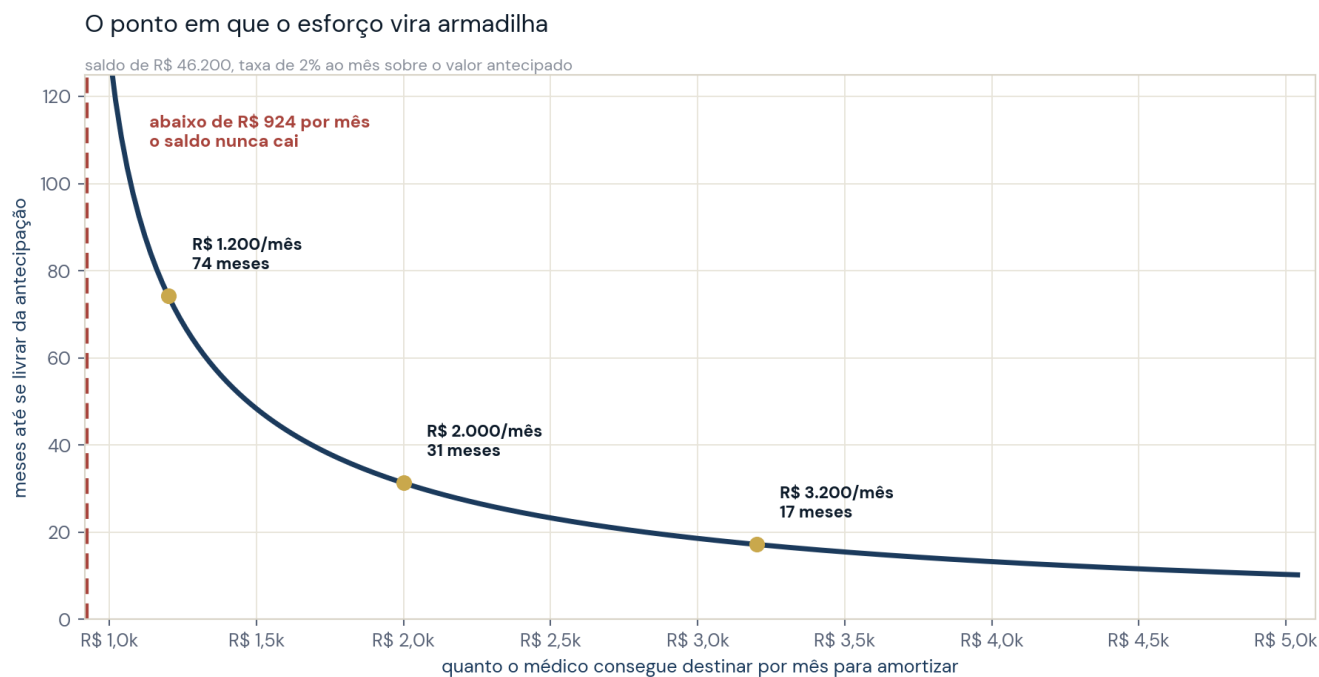


Gráfico 3 · Meses até se livrar da antecipação, em função de quanto o médico consegue destinar por mês. A assíntota vertical é o deságio do primeiro mês.

Esforço mensal	Meses até quitar	Em anos	Deságio total pago no caminho
R\$ 900			nunca — não cobre nem o deságio do mês
R\$ 1.000	130	10,8	R\$ 83.937
R\$ 1.100	93	7,7	R\$ 55.599
R\$ 1.200	74	6,2	R\$ 42.861
R\$ 1.500	48	4,0	R\$ 26.302
R\$ 2.000	31	2,6	R\$ 16.412
R\$ 2.500	23	1,9	R\$ 12.055
R\$ 3.200	17	1,4	R\$ 8.866
R\$ 4.000	13	1,1	R\$ 6.864
R\$ 5.000	10	0,9	R\$ 5.400

Tabela 6 · Saldo de R\$ 46.200 a 2,0% ao mês. O esforço mensal paga primeiro o deságio do mês; só o excedente reduz o saldo.

A COMPARAÇÃO QUE DECIDE ONDE INVESTIR ENERGIA

Partindo de R\$ 1.500 por mês de esforço, a saída leva 48 meses e custa R\$ 26.302 de deságio no caminho. A partir daí existem dois caminhos.

Caminho A — negociar a taxa de 2,0% para 1,5%. Economiza R\$ 231 por mês e reduz a saída para 42 meses, com R\$ 16.256 de deságio total.

Caminho B — manter a taxa e encontrar R\$ 1.000 de excedente mensal. Reduz a saída para 23 meses, com R\$ 12.055 de deságio total.

O caminho B economiza R\$ 14.247 contra R\$ 10.046 do caminho A, e chega 18 meses antes. E há uma assimetria que a tabela não mostra: negociada a taxa, o ganho acaba ali. Encontrado o excedente, ele continua existindo depois que a dívida termina — e passa a ser aporte.

O que acontece depois

Quitado o saldo, o médico não volta ao ponto zero. Ele passa a carregar R\$ 46.200 em caixa — dinheiro que ele já tinha, apenas antes vendido — rendendo CDI. São R\$ 396 por mês líquidos. Somados aos R\$ 924 que ele deixa de pagar, a virada no fluxo mensal é de **R\$ 1.320**, ou R\$ 15.835 por ano.

O mesmo dinheiro, dois destinos

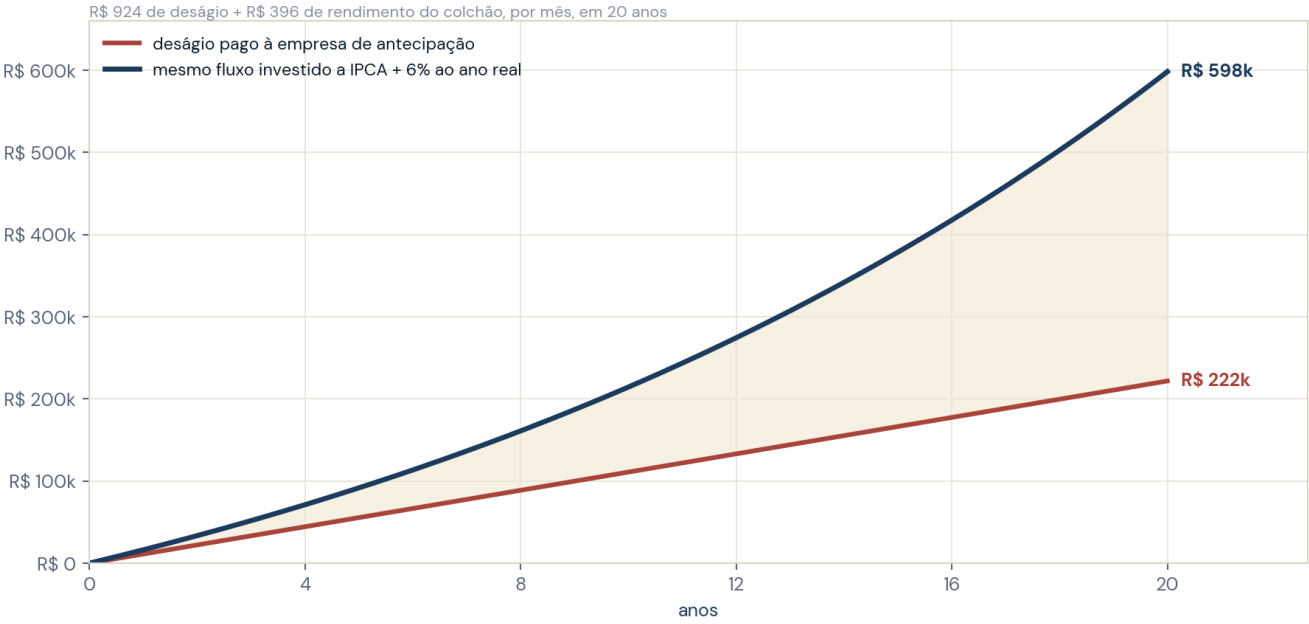


Gráfico 4 · Deságio pago acumulado contra o mesmo fluxo investido a IPCA + 6% ao ano real. Ambos em termos reais, já descontada a inflação.

Horizonte	Só o deságio evitado R\$ 924/mês	Deságio + rendimento do colchão R\$ 1.320/mês
5 anos	R\$ 64.205	R\$ 91.691
10 anos	R\$ 150.125	R\$ 214.395
20 anos	R\$ 418.977	R\$ 598.344
30 anos	R\$ 900.450	R\$ 1.285.939

Tabela 7 · Valor futuro em termos reais. A coluna da direita inclui o rendimento do colchão já constituído.

A segunda janela e a leitura justa

Qualquer conclusão que só sobreviva a um cenário é frágil. Este estudo foi rodado em duas janelas de uso e sob duas convenções de cotação — e uma delas contraria a tese central.

Janela A — uso pontual

Três antecipações por ano, em meses de aperto real. Custo anual de R\$ 2.772. Ao longo de vinte anos, o mesmo dinheiro investido daria R\$ 104.744 em termos reais. É dinheiro, mas não é o que decide uma vida financeira. **Para uso pontual, a antecipação é um seguro de liquidez com preço razoável.**

Janela B — uso estrutural

Doze antecipações por ano, todo mês, indefinidamente. Custo anual de R\$ 11.088. Em vinte anos, R\$ 418.977 em termos reais — e R\$ 598.344 contando o colchão. **A mesma ferramenta, ao mesmo preço, usada com frequência quatro vezes maior.**

O QUE SOBREVIVE ÀS DUAS JANELAS

Não é "antecipação é ruim" — o preço está certo e o estudo mostrou isso na seção 05. É isto: **a frequência importa mais que o preço.** O mesmo instrumento, à mesma taxa, é um serviço razoável usado três vezes por ano e uma erosão patrimonial usado doze. Nenhuma negociação de taxa compensa a mudança de frequência.

A convenção que não encontramos

Existe uma segunda forma de cotar antecipação: o **deságio único**, um percentual fixo cobrado uma vez sobre o valor de face, independente do prazo. É a convenção usual na antecipação de recebíveis de cartão. **Não a encontramos em nenhuma proposta de antecipação de plantão**, e a aritmética explica por quê.

Um deságio único de 2% sobre um plantão que cairia em 90 dias custaria 8,5% ao ano — **abaixo do CDI líquido** de 10,8%. Nesse ponto, o médico antecipa, aplica e termina com mais patrimônio do que se tivesse esperado. Seria dinheiro entregue de graça pela financeira, e por isso não é ofertado. A grade completa dessa convenção está na Tabela 9, no fim do documento, como referência para quem eventualmente receba uma proposta assim — mas o leitor deve tratá-la como exceção, não como alternativa disponível.

Onde a antecipação realmente cria valor

A régua honesta é o **deságio neutro**: o ponto em que antecipar e investir empata com esperar o pagamento.

A linha em que antecipar deixa de ser prejuízo

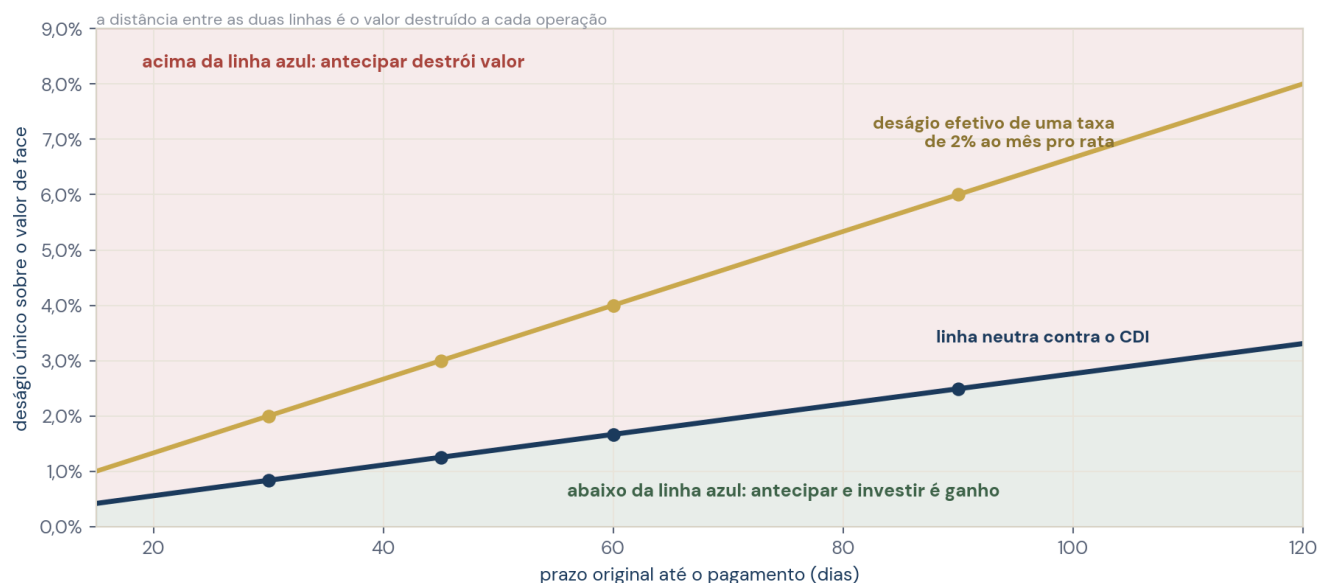


Gráfico 5 · A linha azul é o deságio em que antecipar empata com esperar. A linha dourada é o deságio efetivo de uma taxa de 2% ao mês pro rata.

Prazo	Deságio neutro	Equivalente ao mês	Acima disso, antecipar destrói valor
30 dias	0,84%	0,84%	a partir de R\$ 258 por mês no caso-base
45 dias	1,25%	0,84%	a partir de R\$ 386 por mês no caso-base
60 dias	1,67%	0,83%	a partir de R\$ 514 por mês no caso-base
90 dias	2,49%	0,83%	a partir de R\$ 767 por mês no caso-base

Tabela 8 · Deságio neutro. Abaixo desses valores, antecipar e investir gera ganho; acima, gera perda.

A régua converge para um número estável: **cerca de 0,83% ao mês sobre o valor de face**, praticamente independente do prazo. O Gráfico 5 mostra o essencial: a linha dourada, que é a taxa de 2% ao mês pro rata, **abre distância da linha azul conforme o prazo cresce**. Quanto mais o contratante demora, mais valor a operação destrói — e é justamente nos contratos de prazo longo que antecipar parece mais necessário.

O CASO EM QUE ANTECIPAR É CLARAMENTE CERTO

Quando é pontual e o dinheiro tem destino com retorno superior ao custo. Um médico que antecipa três vezes no ano para não entrar no cheque especial de 139,8% ao ano está tomando a decisão certa por uma margem enorme. Um médico que antecipa a 26,8% ao ano, todo mês, para cobrir despesa corrente, não está comprando liquidez. Está financiando o próprio padrão de vida a juros de financiamento de veículo, sem prazo e sem fim.

Onde este estudo pode estar errado

As seis objeções mais fortes que um leitor técnico faria, e as respostas.

1. "Vocês não têm as taxas reais praticadas." Temos algumas, observadas em campo, e é delas que sai o caso-base de 2% ao mês. O que não existe é uma média de mercado publicada, e isso está declarado na segunda página. Por isso o estudo entrega uma grade de 1,5% a 5% em quatro prazos, em vez de um veredito. A conclusão estrutural — de que o prazo é o multiplicador e o descasamento é um nível — não depende de nenhuma taxa específica.

2. "Meu plantão não vale R\$ 2.200." Provavelmente não. Por isso a Tabela 1 traz três perfis, de R\$ 1.250 a R\$ 3.168 por plantão. E o número que mais importa não muda entre eles: os três perdem 5,04 plantões por ano. A antecipação cobra em fração de tempo, não em reais — e a fração é a mesma para todo mundo.

3. "Eu não tenho R\$ 46.200 sobrando para deixar parado." Ninguém tem — é justamente por isso que a seção 07 existe. A saída não exige o valor cheio de uma vez; exige excedente mensal. E cada real amortizado reduz o deságio do mês seguinte, o que acelera o processo sozinho.

4. "O deságio é despesa dedutível na minha pessoa jurídica." Verdade, e reduz o custo líquido pela alíquota efetiva. Mas o rendimento do colchão também é tributado, e o estudo ignorou os dois lados. Um médico no Simples com alíquota efetiva de 10% veria o custo cair de 26,8% para cerca de 23,9% ao ano — o que muda a comparação com o consignado, mas não muda nada na seção 06, que é sobre estrutura e não sobre preço.

5. "Vocês ignoraram IOF, tarifa de cadastro e ad valorem." Sim, deliberadamente, e isso **favorece a antecipação**. Como registrado na seção 03, as propostas examinadas não permitem determinar se esses custos existem. Quando a operação é estruturada como desconto e não como compra de direitos creditórios, incide IOF de 0,38% fixo mais 0,0082% ao dia, além de ad valorem que fontes de mercado situam entre 0,5% e 2%. Com esses custos, todas as células das Tabelas 3 e 9 sobem.

6. "Minha renda de plantão não é constante." Esta é a limitação mais séria do modelo. A mecânica de normalização descrita na seção 06 pressupõe volume de trabalho estável. Renda volátil torna o buraco maior e mais difícil de dimensionar — o que **reforça** a conclusão em vez de enfraquecê-la: quanto mais irregular a renda, maior o colchão necessário e mais caro sair depois.

O QUE SOBREVIVE A TODAS AS SEIS

Nenhuma dessas objeções toca o achado central, porque ele não é sobre preço — e o preço, como a seção 05 mostrou, está certo. O achado é que o descasamento entre o plantão e o pagamento é um problema de nível, que cobra uma vez. Convertê-lo em despesa mensal permanente é uma escolha: geralmente involuntária, quase sempre não calculada, e sempre reversível.

Base de dados e premissas

Todo número deste documento sai da tabela abaixo e do arquivo CSV que acompanha o estudo. Nada foi escrito de memória.

Grade do deságio único, para referência

Deságio único	30 dias	45 dias	60 dias	90 dias
1,0%	13,0%	8,5%	6,3%	4,2%
1,5%	20,2%	13,0%	9,6%	6,3%
2,0%	27,9%	17,8%	13,1%	8,5%
2,5%	36,1%	22,8%	16,7%	10,8%
3,0%	44,9%	28,0%	20,4%	13,1%
4,0%	64,3%	39,3%	28,2%	18,0%
5,0%	86,7%	51,6%	36,6%	23,1%

Tabela 9 · Custo anual equivalente de um deságio único, por prazo. Convenção não encontrada no mercado de antecipação de plantão; incluída como referência. Em verde, as combinações abaixo do CDI líquido de 10,8%.

Parâmetro	Valor	Origem
Faturamento mensal de plantões	R\$ 30.800	caso-base definido antes do cálculo
Plantões por mês · 12 horas	14	caso-base
Valor do plantão	R\$ 2.200,00	calculado
Horas por mês	168	calculado
Valor da hora bruta	R\$ 183,33	calculado
Referência FENAM · plantão de 12 horas em 2026	R\$ 3.168,38	Federação Nacional dos Médicos
Selic meta	14,00%	Copom, 6 de agosto de 2026
CDI · proxy pela Selic over	13,90%	Banco Central
CDI líquido de IR de 22,5%	10,77%	calculado
IPCA acumulado em 12 meses	4,64%	IBGE · ver ressalva de divergência
Retorno real de longo prazo	IPCA + 6%	premissa padrão Doctor Invest
Prazo do caso-base	45 dias	meio da faixa relatada
Deságio do caso-base	3,0%	3,0% ao mês pro rata em 45 dias

Tabela 10 · Parâmetros do modelo, fixados antes de qualquer cálculo.

Fórmulas

- **Custo anual do deságio único:** $(1 + (1 - d))$ elevado a $(365 + \text{prazo})$, menos 1.
- **Custo anual da taxa mensal pro rata:** o mesmo, com $d = \text{taxa} \times \text{prazo} + 30$.
- **Saldo devedor equivalente:** faturamento mensal $\times$ prazo em meses.
- **Taxa mensal sobre o saldo:** deságio pago no mês $\div$ saldo devedor.
- **Meses até quitar:** $-\ln(1 - \text{saldo} \times i + \text{esforço}) \div \ln(1 + i)$, a mesma fórmula de amortização de um empréstimo com prestação constante.
- **Deságio neutro:** $1 - (1 + \text{CDI líquido})$ elevado a $(-\text{prazo} + 365)$.

Fontes

1. Banco Central do Brasil. Estatísticas Monetárias e de Crédito, referência junho de 2026, divulgadas em 30 de julho de 2026. Taxas médias de juros por modalidade.
2. Comitê de Política Monetária do Banco Central. Decisão de 6 de agosto de 2026: meta da Selic em 14,00% ao ano; Selic over em 13,90%.
3. IBGE. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado em 12 meses.
4. Federação Nacional dos Médicos. Parâmetro de plantão de 12 horas para 2026.
5. Páginas institucionais de cinco operadores de antecipação para médicos, consultadas em agosto de 2026 — nenhuma com tabela de preços publicada.
6. Guias de mercado sobre antecipação de recebíveis e antecipação salarial, 2026, para as faixas declaradas da tabela do capítulo O3.
7. Levantamentos de mercado sobre valor de plantão médico em 2026, para as faixas por região e tipo de instituição usadas na construção dos perfis da Tabela 1.
8. Propostas comerciais observadas em campo, base do caso-base de 2% ao mês pro rata. Não constituem amostra estatística e não são identificadas.

O PRÓXIMO PASSO É UMA CONTA, NÃO UMA DECISÃO

Este estudo entrega a régua, não o veredito. As três perguntas que respondem o seu caso são: qual o prazo real de pagamento dos seus contratos, qual a convenção de cotação da taxa que você paga, e quanto de excedente mensal o seu orçamento consegue gerar hoje. Com essas três respostas, a Tabela 6 diz em quantos meses você sai — e se você sai.

Note que a primeira delas não depende de você — depende do contratante, e é a que mais move a conta. A terceira depende inteiramente de você, e é a que resolve. Se quiser fazer esse diagnóstico com apoio, a consultoria financeira da **Doctor Invest** existe exatamente para isso.

Aviso importante. Este material tem caráter exclusivamente informativo e educacional e não constitui recomendação de investimento, oferta, solicitação de compra ou venda de qualquer ativo, nem consultoria de valores mobiliários individualizada, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. Os cenários apresentados foram construídos para fins analíticos e não representam sugestão de contratação, de alocação ou de conduta para qualquer investidor específico. Rentabilidade passada não constitui garantia de rentabilidade futura. Os resultados decorrem de simulação baseada em séries históricas públicas e em premissas declaradas, desconsideram custos operacionais, tributação e encargos como IOF e tarifas, e não refletem as condições efetivamente praticadas por nenhuma instituição específica. As menções a empresas, plataformas e modalidades têm finalidade exclusivamente ilustrativa e analítica, e não constituem juízo sobre a idoneidade ou a adequação de qualquer prestador de serviço. Operações de crédito e de antecipação de recebíveis envolvem custos e riscos; investimentos envolvem risco de perda, inclusive do capital principal. Antes de contratar ou investir, avalie seus objetivos, sua situação financeira e sua tolerância a risco, preferencialmente com o apoio de profissional habilitado.

Doctor Invest · Gestão de investimentos e consultoria financeira para médicos · Hélio Cardoso de Barros, CGA · agosto de 2026.